ARAÇ 4 / 5

4 Aşamalı Klinik Planlayıcı

Teşhis → Hedefler → Mekanik → Kontrol. Her vaka için elle doldurulan, yazdırılabilir planlama formu.

BAŞLAMADAN

Planlayıcı Nasıl Kullanılır?

Formu her yeni vaka için yazdırın; hasta dosyasında saklayın.

> *Plan, problem listesinden doğar. Önce teşhis, sonra hedef, en son mekanik. Sıra bozulursa tedavi uzar.*

1. **Aşama 1 · Teşhis** — Yüz, oklüzyon, yer analizi, sefalometri ve panoramiği doldurun. Panoramik için Araç 1'i, sınıflama için Araç 3'ü kullanın. Bitince problem listesini önem sırasıyla yazın.
2. **Aşama 2 · Hedefler** — Her probleme bir hedef yazın: yüz, molar ve kanin bitirişi, overjet, overbite, orta hat. Çekim kararını Araç 2 ile verin; ankraj ihtiyacını burada belirleyin.
3. **Aşama 3 · Mekanik sıra** — Hedeflere hangi sırayla ulaşacağınızı yazın. Her adımın teli veya yardımcı apareyi bellidir. Bitenleri işaretleyin.
4. **Aşama 4 · Kontrol ve bitirme** — Ara panoramik, braket yeniden pozisyonu, oklüzyonun 6 anahtarı ve pekiştirme planı. Braket sökülmeden önce her satır işaretli olmalı.

Kural

Boş kalan satır, henüz verilmemiş bir karardır. Braketleri yapıştırmadan önce Aşama 1 ve 2 eksiksiz olsun; ardından Araç 5 ile son kontrolü yapın.

Sık hata

Mekanik sırayı alışkanlıkla yazmak. Önce transversal ve ortopedik düzeltme, sonra seviyeleme; derin kapanış açılmadan sagital düzeltmeye geçilmez.

Kutular

Uygun seçeneği işaretleyin; listede yoksa satırın sonuna yazın.

Revizyon

Plan değişirse eski satırı çizin, yanına tarih ve yeni kararı yazın.

PLANLAYICI · SAYFA 1

Aşama 1 · Teşhis

Kayıtlar tamamlanmadan Aşama 2'ye geçmeyin.

Hasta / yaş / tarih

Başvuru şikâyeti

Alışkanlık ☐ Parmak emme ☐ Ağız solunumu ☐ Dil itme ☐ Bruksizm

Yüz

Profil ☐ Düz ☐ Konveks ☐ Konkav

Dudaklar ☐ Rahat ☐ Zorlanıyor ☐ Protrüzif ☐ Retrüzif

Yüz orta hattı / çene ucu

Gülümseme ☐ Fazla dişeti ☐ Geniş bukkal koridor ☐ Normal

Oklüzyon

Molar / kanin (sağ · sol)

Overjet / overbite (mm)

Orta hat üst / alt (mm)

Çapraz / makaslama kapanış

Spee eğrisi ☐ Düz ☐ Orta ☐ Derin

Fonksiyonel kayma (CR–CO) ☐ Yok ☐ Var: ___ mm

TME ☐ Bulgu yok ☐ Ses ☐ Ağrı ☐ Kısıtlı açma

Yer, sefalometri ve kayıtlar

Yer ihtiyacı üst / alt (mm)

Bolton ☐ Uyumlu ☐ Üst fazlası ☐ Alt fazlası

SNA / SNB / ANB · Wits

FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN

Panoramik (Araç 1) ☐ Temiz ☐ Bulgu var →

Periodonsiyum / biyotip ☐ Kalın ☐ İnce ☐ Çekilme var

Büyüme dönemi ☐ Atılım öncesi ☐ Atılımda ☐ Bitmiş

Ayırıcı tanı (Araç 3) ☐ Dental ☐ İskeletsel ☐ Psödo

Problem listesi (önem sırasıyla)

PLANLAYICI · SAYFA 2

Aşama 2 • Hedefler

Her problem için bir hedef. Hedef ölçülebilir olsun.

Yüz hedefi	☐ Profili koru ☐ Dudak desteğini azalt ☐ Dudak desteğini artır
Molar bitiriş sağ / sol	☐ Sınıf I ☐ Tam Sınıf II ☐ Tam Sınıf III
Kanin bitiriş	☐ Sınıf I
Overjet / overbite hedefi (mm)	
Orta hat	☐ Düzelt ☐ Kabul et
Kesici pozisyonu	☐ Koru ☐ Retraksiyon ☐ Kontrollü proklinasyon
Transversal	☐ Gerek yok ☐ RME ☐ Dentoalveolar genişletme
Vertikal	☐ Koru ☐ Derin kapanışı aç ☐ Açık kapanışı kapat
Çekim kararı (Araç 2)	☐ Çekimsiz ☐ Çekim: _____
Ankraj ihtiyacı	☐ Minimum ☐ Orta ☐ Maksimum
Ankraj aracı	☐ TPB ☐ Nance ☐ Mini vida ☐ Elastik

Kabul edilen sınırlar / kompromiler

Hastaya anlatıldı	☐ Seçenekler ☐ Süre ☐ Pekiştirme

PLANLAYICI · SAYFA 3

Aşama 3 • Mekanik Sıra

Sırayı yazın, bitenleri işaretleyin. Bir adım bitmeden sonrakine geçmeyin.

✓	ADIM	TEL / APAREY / YARDIMCI	BAŞLANGIÇ TARİHİ
☐	Ortopedi / genişletme		
☐	Seviyeleme ve hizalama		
☐	Derin kapanış / Spee eğrisi		
☐	Boşluk kapatma		
☐	Sagital düzeltme		
☐	Orta hat		
☐	Detaylandırma (tork, rotasyon)		

Aşama 4 • Kontrol ve Bitirme

Kontrol aralığı

Ara panoramik (kök paralelliği) ☐ Planlandı ☐ Yapıldı

Braket yeniden pozisyonu ☐ Gerek yok ☐ Dişler: _____

Oklüzyonun 6 anahtarı ☐ Molar ☐ Kron açısı ☐ Kron eğimi ☐ Rotasyon ☐ Kontakt ☐ Okluzal düzlem

Overjet / overbite / orta hat ☐ Hedefte

Pekiştirme üst ☐ Sabit lingual ☐ Hawley ☐ Essix

Pekiştirme alt ☐ Sabit lingual ☐ Hawley ☐ Essix

Nüks riski / not

ÖRNEK

Doldurulmuş Örnek

Kurgusal bir vaka. Kendi vakanızda aynı yoğunlukta yazmanız yeterlidir.

1 · TEŞHİS

Hasta	*13 yaş, kız. Şikâyet: "Üst dişlerim önde."*
Yüz	*Konveks profil, geride çene ucu; dudaklar zorlanarak kapanıyor*
Oklüzyon	*Molar ve kanin iki tarafta Sınıf II; overjet 8 mm, overbite 5 mm; derin Spee*
Yer / Bolton	*Üst 2 mm, alt 3 mm yer ihtiyacı; Bolton uyumlu*
Sefalometri	*SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA 97°*
Diğer	*Panoramik temiz; kalın biyotip; büyüme atılımında; kayma yok*
Tanı (Araç 3)	*İskeletsel Sınıf II bölüm 1, mandibular retrognati; yapıcı kapanışta profil düzeliyor*
Problem listesi	*1) Sagital (overjet) 2) Derin kapanış 3) Hafif çapraşıklık 4) Dudak yetmezliği*

2 · HEDEFLER

Yüz / sagital	*Mandibulayı öne yönlendir; molar ve kanin Sınıf I*
Overjet / overbite	*2–3 mm / 2–3 mm*
Çekim / ankraj	*Çekimsiz (Araç 2: alt kesiciler zaten proklinasyonda, izlenecek); orta ankraj*
Hastaya anlatıldı	*Fonksiyonel aparey uyumu, iki aşama, pekiştirme süresi*

3 · MEKANİK SIRA

1. Ortopedi	*Twin Block; düzenli uyum kontrolü*
2. Seviyeleme	*Sabit apareye geçiş: NiTi dizisi → çelik*
3. Derin kapanış	*Spee eğrisinin düzeltilmesi, ön intrüzyon*
4. Detaylandırma	*Hafif Sınıf II elastikleri gerektiğinde; tork ve rotasyon*

4 · KONTROL VE BİTİRME

Kontroller	*Düzenli aralıkla; ara panoramikte kök paralelliği*
Bitirme	*6 anahtar kontrolü; overjet ve overbite hedefte*
Pekiştirme	*Üst Essix, alt sabit lingual; nüks riski: alt kesici proklinasyonu*

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Formu doldurduysanız braketleri yapıştırmadan önce **Araç 5 · Planlama Hataları Radarı** ile planı tarayın. Planlama mantığının tamamı **Modül 03 Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe** bölümünde.